

التحويل البولي القاري عبر الجلد كيسٌ داخلي يُصنع من أمعائك الخاصة، يخزّن البول داخل جسمك، مع فتحة صغيرة محكمة (فُغرة، وغالبًا في السرة). بدلًا من الكيس الخارجي، تُفَرِّغ الكيسَ بإدخال قسطرة عبر الفتحة عدة مرات يوميًا. الكيس الأمعائي من نوع Indiana Pouch هو الأكثر شيوعًا.

عن هذه العملية

تُعاد تشكيل قطعة من الأمعاء الغليظة والدقيقة لتكوين خزان منخفض الضغط داخل البطن؛ تُصرَّف الحالبان (الأنبوبان القادمان من الكليتين) داخله. قناة قصيرة ذات صمام أحادي الاتجاه تُوصَّل بالجلد — في الغالب عند السرة — كُفْرة صغيرة مسطحة تظل جافة بين عمليات القسطرة.

- تُدخل القسطرة لإفراغ الكيس نحو كل 4-6 ساعات.
- **تغسل (تروي)** الكيس لإزالة المخاط.
- **لا كيس خارجي** — فقط قطعة شاش صغيرة على الفُغرة.

هو خيار مناسب لمن يرفض الكيس الخارجي، ولا يصلح له الكيس البولي الداخلي (neobladder) أو لا يريده، وقادر على إجراء القسطرة باستمرار — مما يتطلب يدين ثابتتين وبصرًا جيدًا أو مساعد.

هل هو آمن؟

هذا خيار قاري راسخ. العملية أطول وأكبر من عملية الناسور البولي (conduit)، وتستلزم القسطرة مدى الحياة. المخاطر تشمل: نزيفًا وعدوى وتسربًا، وصعوبة في إدخال القسطرة أو تضيق الفُغرة أو تسربها (قد يحتاج إلى تدخل بسيط)، وحصى في الكيس، ومخاطًا، وعدوى بولية، وتغيرات مزمنة في الأملاح والفيتامينات والكليتين تُتابع في الفحوصات الدورية.

تعلم المصطلحات

التحويل القاري

نظام بولي محكم — أنت تتحكم في موعد إفراغه.

Indiana Pouch

الكيس القاري الأكثر شيوعًا، يُبنى من القولون الأيمن والأمعاء الدقيقة.

الخزان (الكيس)

الكيس الداخلي المصنوع من الأمعاء لتخزين البول.

الفُغرة

الفتحة الجلدية الصغيرة (غالبًا السرة) التي تُدخل منها القسطرة.

القسطرة

إدخال أنبوب رفيع عبر الفُغرة لإفراغ الكيس.

الري (الغسيل)

تدفيق الماء في الكيس لإزالة المخاط.

الحالبان

الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكليتين ويصرفانه داخل الكيس.

المخاط

سائل زلق تُفرزه الأمعاء؛ إزالته جزء من الرعاية اليومية.

هل سيولم؟ تُجرى العملية تحت التخدير العام فلا تشعر بشيء خلالها. بعدها، توقّع آلامًا في البطن، وتحتاج الأمعاء بضعة أيام لاستعادة حركتها. تصحو وفي الكيس أنبوب (مع دعامات ناعمة) يبقى نحو 3-4 أسابيع للشفاء — تغسله لإزالة المخاط. يمكث معظم المرضى في المستشفى نحو 5-8 أيام.

كيف تستعدّ (قبل العملية)

بعد العملية

- تعود للمنزل في نحو 5-8 أيام والأنبوب لا يزال في الكيس لمدة 3-4 أسابيع؛ اغسله بانتظام لإزالة المخاط.
- بعد إزالته وشفاء الكيس، أجر القسطرة عبر الفُغرة كل 4-6 ساعات واروِّها لإزالة المخاط.
- تبقى الفُغرة جافة — تُغطى بقطعة شاش صغيرة (بلا كيس).
- المخاط طبيعي؛ اشرب السوائل؛ متابعة مدى الحياة (فيتامين B12، فحص الكيس). تجنّب الرفع الثقيل نحو 6 أسابيع.

- تُجرى تحت التخدير العام — اتبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام، وقف مميّعات الدم حسب التوجيه). قد تحتاج إلى تحضير للأمعاء.
- يخطّط فريقك لموضع الفُغرة (غالبًا السرة) ويتأكد من قدرتك — أو قدرة مساعدك — على القسطرة مدى الحياة.
- أقلع عن التدخين، ورثب مساعدة في المنزل بعد العملية.

أخير فريقك مسبقًا إذا كنت:

- تتناول مميع دم، أو لديك عدوى حالية
- تعاني من مرض في الأمعاء أو مشكلة في الكليتين، أو أي صعوبة في اليدين أو البصر تؤثر على القسطرة

ما الذي يحدث أثناء العملية

اتصل بفريقك الطبي أو اطلب العناية فورًا إذا:

- عجزت عن إدخال القسطرة أو لم يخرج بول — قد يمتلئ الكيس فوق طاقته ويجب إفراغه عاجلاً
- أصابتك حمى أو رجفة
- عانيت من ألم شديد في البطن أو قيء أو انعدام الغازات والبراز
- لاحظت نزيفًا غزيرًا أو جلطات تسدّ القسطرة، أو احمرارًا وإفرازات في الجرح

1

تنام تحت التخدير وتُعطى مضادات حيوية.

2

تُعزل قطعة من الأمعاء وتُعاد وصل بقيتها.

3

تُعاد تشكيل الأمعاء كيسًا، وتُوصّل قناة ذات صمام أحادي الاتجاه بالجلد كفُغرة.

4

يُوصّل الحالبان بالكيس، ويُوضع أنبوب ودعامات ناعمة أثناء فترة الشفاء.

ثلاثة أمور تذكّرها

1. الكيس القاري (Indiana Pouch) يخزّن البول داخلك مع فتحة محكمة تُفَرِّغ بالقسطرة — بلا كيس خارجي.
2. ستُجري القسطرة عبر الفُغرة كل 4-6 ساعات وتغسلها لإزالة المخاط، مدى الحياة — لذا تحتاج يدين ثابتتين أو مساعدًا.
3. استعدّ بالصيام وتحضير الأمعاء، وأقلع عن التدخين، ورثب مساعدة. اطلب العناية فورًا إن عجزت عن إدخال القسطرة أو لم يخرج بول.